



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سحر جمال الدين احمد على

المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : الهرم

رقم البطاقة : 26510062101781 رقم التليفون : 01003253252

العمر (تاريخ الميلاد) : 06-10-1965 المهنة : ربه منزل

العنوان : 4 ش محمد رجب

المجزر الالى الهرم الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودورونيك [14157]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /د. /د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سحر جمال الدين احمد علي National ID: 26510062101781	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



MDT FORM

Name:	Sahar Gamal El-Sayed Ali	MRN:	4295
Age:	60 Y	ID:	
Menopausal Sta:	post	Phone:	01030462423
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:	free	Reason Of MDT:	possibility of radical tt

Clinical Data:

BX: IDC

ER: 8/8 **PR:** 8/8 **HER2:** 0 **KI67:** 10

Sonomammography:

Mets Workup:

History:

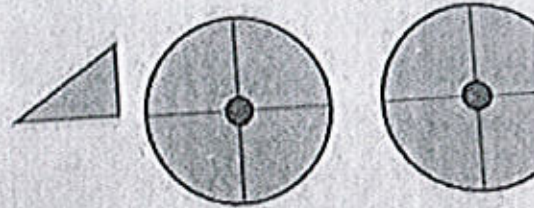
left breast cancer (luminal) with lung nodule started AI since 11/2024 till now.
last ct cap in 15/2/2026 >> CR
after consultation dr hanan for MDT (revision of ct and possibility of radical tt)

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

For new Sonomammography then Left MRM vs Left simple mastectomy +
CL MD

R



T N M

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition
د/ خالد عبد العزيز		د/ منى زكي		

Name : SAHAR GAMAL AL DIN AHMED

Date : 15-02-2026 10:31

Branch : Portable

Medical No. : GRI-90800

Ref.Physician Prof : CT CAP+C

Ins.Company :

**MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE
CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:**

I- CHEST:

- Bilateral few subcentimetric pulmonary nodules, largest one seen at right middle lobe anterior basal segment measuring about 2mm.
- Bilateral subcentimetric axillary lymph nodes for U/S correlation
- No consolidation or cavitation.
- No pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No plural or pericardial collection.
- No gross cardiomegaly
- Dorsal spondylosis.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Mildly enlarged liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, both kidneys, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

Opinion:

- Bilateral few subcentimetric pulmonary nodules for follow up.
- Mild hepatomegaly.

Dr. Nourhan Mohamed,ML

Name : الأستاذ / سحر جمال الدين احمد
Patient No. : 26510062101781
Lab No. : 3675/24
Sex : Female
Age : 58 Y
Referring Doc :

Request No. : 13004154
Request Date : 28/09/2024
Verification Date : 12/10/2024
Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Left breast mass.

Nature of Specimen:
Tru-cut biopsy collected at 28/9/2024.

Gross Examination:

- Three grayish white tissue cores up to 1cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma with lobular features.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (2+2+1) Gradell .
- * Ductal carcinoma in situ: Not detected.
- * Perineural invasion: Not detected.
- * Angiolinvasion: Not detected.
- * Microcalcifications: Not detected.
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
 - ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (score 8/8).
 - PR: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (score 8/8).
 - Her2: No membrane reaction tumor cells (score 0).
 - Ki67: 10% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II with lobular features.

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 18/03/2025 10:05:39

Page 1 of 2

Printing By : hermal



شرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt